

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade, ou não, de cobertura, por parte da operadora de saúde agravante, do tratamento oncológico com protocolo específico (VAC e Pembrolizumabe) prescrito ao paciente, diagnosticado com Sarcoma de Ewing metastático.

Inicialmente, importa ressaltar que a relação jurídica entre as partes está indiscutivelmente submetida à égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante pacificado pelo C. STJ na Súmula 608. In verbis:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Tal qualificação impõe a incidência dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, exigindo a interpretação mais favorável à parte hipossuficiente (art. 47, CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que o tratamento foi prescrito por médico oncologista habilitado (laudo médico de Id 148662363 – autos de origem 0867805-66.2025.8.14.0301), diante de patologia grave e progressiva (sarcoma de Ewing metastático), com comprovação técnica e científica da sua eficácia. Consta, de fato, a negativa formal da operadora sob o argumento de que a medicação se encontra fora do Rol da ANS.

Contudo, tal argumento da operadora de saúde não prevalece.

De acordo com o julgamento da ADI 7265, concluído pelo Supremo Tribunal Federal em 18/09/2025, foi adotada a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, possibilitando a cobertura

de tratamentos fora do rol, desde que preenchidos cinco requisitos cumulativos:

1. Prescrição por profissional habilitado;
2. Ausência de negativa expressa da ANS ou pendência de inclusão no rol;
3. Inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;
4. Comprovação científica de eficácia e segurança do tratamento;
5. Registro do medicamento na Anvisa.

No presente caso, todos esses requisitos estão preenchidos, conforme demonstra a documentação médica e a Nota Técnica nº 2011/2022 do NATJUS, que reconhece a eficácia da terapia oncológica com Pembrolizumabe, especialmente quando há risco elevado de progressão da doença.

Nesse sentido, a Jurisprudência dos Tribunais pátrios é cristalina na garantia da cobertura do tratamento essencial à vida do paciente, vejamos:

Ementa: Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Concessão de tutela antecipada para impor à seguradora o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMAB, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a R\$ 100.000,00, à autora, portadora de sarcoma metastático. Negativa de cobertura, por se tratar de medicamento off label, experimental, e porque o rol da ANS é taxativo. Presença dos pressupostos legais, em prol da autora-agravada. Inteligência do art. 18, X, da RN 465/2021 da ANS e da Súmula 102 deste TJSP. Manutenção do valor da multa cominatória. Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento 23373273220248260000 São Paulo JurisprudênciaAcórdãopublicado em 12/01/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE SARCOMA PLEOMÓRFICO – REQUERIMENTO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – APLICAÇÃO DIRETA DO CDC AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 1º, CAPUT DA LEI Nº 9.656 /1998 – NEGATIVA DO MEDICAMENTO EMBASADA NA JUSTIFICATIVA DE SER O TRATAMENTO INDICADO OFF-LABEL E CARENTE DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS ELIDIDA PELA LEI Nº 14.454 /2022 – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO, SUBSCRITO POR ESPECIALISTA E COMPROBATÓRIO DA AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS E DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PARA A MELHORA DO AUTOR – VARIAÇÃO RARA DE SARCOMA – INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS – LIMITAÇÕES CONTRATUAIS ABUSIVAS E NULAS – INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR ADERENTE E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, I, C E II, G DA LEI Nº 9.656 /1998 E DO ART. 18, IX DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL À COBERTURA DE DOENÇAS NÃO AUTORIZATIVA DA RESTRIÇÃO AOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS – DEVER DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC – MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001268- 54.2021.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 16.11.2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA

PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE . CARCINOMA (CID C609.9). MEDICAMENTO INDICADO PELA MÉDICO ASSISTENTE. PEMBROLIZUMABE/KEYTRUDA REGISTRADO NA ANVISA . RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1 . O sucesso do requerimento de tutela provisória está subordinado à demonstração simultânea dos pressupostos fundamentais insculpidos no art. 300 do CPC, vale dizer, a probabilidade de existência do direito postulado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O médico assistente, conhecedor das condições do paciente, é quem está habilitado a indicar a melhor opção, dentre os métodos disponíveis, para a realização do tratamento, não cabendo discussão sobre a eficácia ou não do medicamento indicado . 3. Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ?não há falar em rol de cobertura no que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS - devendo ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente? (AgInt no REsp n. 1.946 .731/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022). 4 . No caso concreto, a probabilidade do direito resta demonstrada, visto que o medicamento possui registro na ANVISA (Keytruda - Pembrolizumabe associado à Paclitaxel) e foi indicado por médica especialista na área, após a paciente ter se submetido a outros tratamentos (quimioterapia e radioterapia), sem efetivo sucesso. Outrossim, a urgência da medida justifica-se diante do cenário fático dos autos, considerando o evidente risco de agravamento do estado de saúde da autora, ou até mesmo seu óbito, vez que é portadora de Carcinoma pouco diferenciado de cabeça pescoço (CID C609.9), com positividade para PDL 1. AGRADO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ GO - AI: 50619742420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do quadro apresentado, não há qualquer ilegalidade na decisão de origem (e referendada monocraticamente) que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado. O risco alegado pela agravante é meramente econômico, enquanto o risco para o autor é à sua saúde e à própria vida, caracterizando, pois, inequivocamente, o *periculum in mora* inverso.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRADO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** OU **AGRAVO INTERNO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora